SEMINAR SEKOLAH PASCASARJANA IPB · PROGRAM STUDI ILMU GIZI · SENIN, 2 NOVEMBER 2026

IPB University
Bogor Indonesia

Pengembangan Media Edukasi Gizi Online SHINING bagi Calon Pengantin

Evaluasi Proses Implementasi dan Pola Penggunaan Media Sosial

Marhamah[1], Hardinsyah[2], Cesilia Meti Dwiriani[2], Lilik Kustiyah[2], Irman Hermadi[3]

[1]Program Doktor Ilmu Gizi, FKGiz IPB • [2]Program Studi Ilmu Gizi, FKGiz IPB • [3]Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA IPB

Program Studi Ilmu Gizi, FKGiz IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor
0813-8172-4884
am_marhamah@apps.ipb.ac.id

SHINING
Sehat Sebelum Hamil itu Penting
Edukasi gizi prakonsepsi online 8 minggu berbasis *Health Belief Model* (HBM)

Abstrak

Latar belakang. Bukti tentang penggunaan media sosial (medsos) calon pengantin (catin) dan kinerja edukasi gizi prakonsepsi online di lapangan di Indonesia masih terbatas.

Tujuan. Mengevaluasi implementasi platform web SHINING kelompok kontrol serta menganalisis penggunaan medsos catin dan hubungannya dengan pengetahuan gizi prakonsepsi, sikap berbasis HBM, dan IMT.

Metode. *Cross-sectional* dan evaluasi proses; data awal catin Kota Binjai (Juli–Oktober 2026): 198 pendaftar, 74 dengan data lengkap.

Hasil. Hanya 38,9% menyelesaikan keenam instrumen; penurunan terbesar sebelum tes pengetahuan 48 butir. Kiriman ganda 13,8% dan galat formulir menghilangkan blok makanan pokok pada 26,9% FFQ. WhatsApp dominan (59,5%); 73,0% mengakses medsos ±setiap jam. Pengetahuan baik 59,5% dan berkorelasi dengan sikap (r=0,414; p<0,001), namun 51,4% berat badan lebih/obesitas. IMT lebih rendah berhubungan dengan durasi medsos lebih lama (r=−0,331; p=0,004) dan sumber akun tenaga kesehatan; kebiasaan memeriksa kebenaran informasi berhubungan dengan sikap lebih positif (r=0,287; p=0,014).

Simpulan. Edukasi online perlu mengarahkan catin ke sumber kredibel dan membiasakan verifikasi informasi; platform perlu instrumen ringkas, konfirmasi penyimpanan di server, dan uji coba pada kelompok sasaran.

Kata kunci: calon pengantin, edukasi online, evaluasi proses, gizi prakonsepsi, media sosial

1 Pendahuluan

Latar belakang

±50%
orang dewasa Indonesia berat badan lebih/obesitas (Pengpid & Peltzer 2017)

44–77%
catin di Bogor & Jakarta Barat berpengetahuan gizi kurang (Melani & Kuswari 2019; Zahra et al. 2024)

72,78%
penduduk mengakses internet, didominasi Gen Z (34,49%) & milenial (31,56%); 77,57% untuk medsos (BPS 2025)

±50%
unggahan gizi akun populer tidak akurat (Denniss et al. 2024)

- Masa prakonsepsi periode kritis memperbaiki gizi & kesehatan catin sebagai calon ayah dan ibu, tetapi sering diabaikan (Stephenson et al. 2018).
- Dewasa muda aktif mencari info kesehatan di medsos (Lim et al. 2022), padahal misinformasi gizi menyebar luas (Wang et al. 2019; Suarez-Lledo & Alvarez-Galvez 2021). Dalam HBM, medsos = *isyarat bertindak*, bergantung pada informasi yang dibaca dan cara menilainya (Janz & Becker 1984).
- Edukasi online catin memberi hasil beragam (Atmaka et al. 2022); intervensi prakonsepsi berbasis HP efeknya masih terbatas (Musgrave et al. 2023).
- Angka berhenti tinggi (*law of attrition*) (Eysenbach 2005; Meyerowitz-Katz et al. 2020), sehingga cara platform dikembangkan, diubah, dan digunakan perlu dilaporkan (Eysenbach 2011).
- Di negara berpenghasilan rendah–menengah, laporan intervensi prakonsepsi online masih terbatas; HP spesifikasi rendah, HP bersama, dan jaringan tidak stabil menjadi hambatan tersering (Amiri et al. 2023).

Tujuan | **(1)** Mengevaluasi proses implementasi platform web media edukasi SHINING, meliputi penyelesaian pengisian dan mutu data; **(2)** menganalisis pola penggunaan medsos catin dan hubungannya dengan pengetahuan gizi prakonsepsi, sikap berbasis HBM, dan IMT, sebagai dasar pengembangan edukasi gizi prakonsepsi online yang mudah digunakan.

2 Metode

- **D** **Desain:** *cross-sectional* + evaluasi proses, bagian dari riset pengembangan SHINING (model ADDIE)
- **S** **Subjek:** catin 20–40 tahun, kelompok kontrol; rekrutmen via brosur kode QR & WhatsApp; **198** memenuhi syarat, **74** dianalisis (30 laki-laki, 44 perempuan)
- **I** **Instrumen:** pengetahuan 48 butir (baik >80%); sikap 24 butir, 6 konstruk HBM, Likert 4 poin (positif ≥72); FFQ; IPAQ-SF; kuesioner medsos; IMT dari BB/TB isian sendiri (PNPK 2025)
- **A** **Analisis:** Spearman, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, khi-kuadrat/eksak Fisher; hubungan bermakna diuji ulang dengan kontrol peran; sebelum–sesudah perbaikan: eksak Fisher; p<0,05; Python & SPSS
- **W** **Tempat & waktu:** pembinaan catin Kota Binjai, Sumatera Utara; Juli–Oktober 2026
- **E** **Etik:** KEPK Poltekkes Kemenkes Medan No. 01.26.1986/KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2025; persetujuan elektronik
- **P** **Indikator proses:** penyelesaian & lama pengisian (*timestamp*), kiriman ganda, karantina, data hilang; kemudahan dinilai 15 mahasiswa (skala 1–5)

Fokus makalah: proses implementasi (Tujuan 1) & pola medsos (Tujuan 2), data awal kelompok kontrol; evaluasi dampak dilaporkan terpisah.

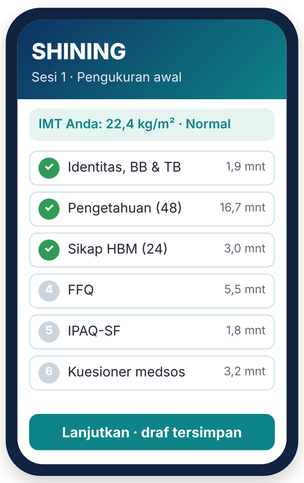
Alur penelitian (model ADDIE)

1. **Analysis** (Analisis kebutuhan) — Kajian literatur, survei awal, analisis kebutuhan
2. **Design** (Desain media) — Desain konten berbasis *Health Belief Model* (HBM)
3. **Development** (Pengembangan) — Pengembangan platform SHINING dan materi edukasi

FOKUS MAKALAH INI

4. **Implementation** (Implementasi) — Uji coba, rekrutmen peserta, implementasi edukasi online
5. **Evaluation** (Evaluasi) — Analisis proses, pola penggunaan media, dan evaluasi dampak

3.1 Hasil · Platform SHINING — Tujuan 1



Gambar 2. Ilustrasi alur sesi 1 (median waktu pengisian)

- **Web satu halaman, ramah HP:** tanpa unduh aplikasi dan tanpa membuat akun.
- **Masuk dengan nama + nomor HP/WA**, lalu cek kelayakan (catin 20–40 tahun) dan persetujuan.
- **Enam instrumen sesi 1:** identitas (BB & TB), pengetahuan, sikap HBM, FFQ, IPAQ-SF, kuesioner medsos.
- **Umpan balik IMT & status gizi** langsung tampil sebagai informasi sekaligus *engagement*.
- **Tersimpan otomatis ke Google Sheets**; nomor HP/WA sebagai penanda peserta.
- **Kiriman berulang ditandai**; data tak dikenali masuk **lembar karantina** untuk verifikasi manual.
- **Penilaian awal (15 mahasiswa):** kelima aspek mudah (rerata 4,40–4,73 dari 5; total 22,8 ± 2,3 dari 25); terendah pada pengisian kuesioner.



Gambar 3. Tampilan asli SHINING di HP (mulai.edukasi-catin.id)

3.2 Hasil · Pengembangan Iteratif Platform — Tujuan 1

PERIODE	MASALAH TERDETEKSI	PERUBAHAN
Akhir Juli	**MASALAH** Halaman persetujuan tidak tersimpan; angka nol di depan nomor HP hilang; status "selesai" hanya tersimpan di HP	**PERBAIKAN** Skrip ditulis ulang (normalisasi nomor, lembar karantina, penanda duplikat); status selesai dikonfirmasi server; cegah kirim ganda
Agustus	**PENILAIAN AWAL** Kemudahan dan keterbacaan dinilai oleh 15 mahasiswa	**CATATAN** Tidak ada masalah besar yang dilaporkan
Awal Oktober	**MASALAH** Progres hilang saat berganti telepon; isian kosong	**PERBAIKAN** Progres dilacak per nomor telepon; validasi isian kosong; pengiriman ulang otomatis
Pertengahan Oktober	**MASALAH** Blok makanan pokok FFQ hilang saat dikirim; halaman awal terlalu banyak tahap	**PERBAIKAN** Simpan draf otomatis; blok makanan pokok wajib; persetujuan berlapis; kartu "selamat datang kembali"
Akhir Oktober	**STATUS** Pendaftaran kelompok kontrol ditutup	**TINDAK LANJUT** Data dikunci untuk analisis

13,8% kiriman berulang (186/1.344); 68,3% dari halaman daftar & persetujuan yang terbuka ulang

22/23 rekaman karantina terjadi di minggu pertama, terutama format nomor belum dinormalisasi

26,9% → 0% FFQ tanpa blok makanan pokok sebelum vs sesudah simpan draf (29/108 vs 0/13; p=0,04)

3.3 Penyelesaian Instrumen Sesi 1 — Tujuan 1 — n = 198

TAHAP	DIKIRIM, N (%)	VALID	MEDIAN (RAK), MNT
Persetujuan	171 (86,4%)	–	–
Formulir identitas	161 (81,3%)	160	1,9 (1,1–2,9)
Tes pengetahuan (48 butir)	107 (54,0%)	**106**	**16,7 (10,7–34,4)**
Skala sikap (24 butir)	96 (48,5%)	94	3,0 (1,6–4,7)
FFQ	92 (46,5%)	88	5,5 (4,0–7,8)
Kuesioner medsos	82 (41,4%)	80	3,2 (2,1–4,1)
IPAQ-SF	82 (41,4%)	67	1,8 (1,2–2,7)
Keenam instrumen	77 (38,9%)	**59**	–

Penurunan terbesar (81,3% → 54,0%) terjadi **sebelum tes pengetahuan**, instrumen terpanjang; kuesioner panjang menurunkan penyelesaian dan mutu jawaban (Galesic & Bosnjak 2009). Setelah perbaikan pertengahan Oktober, penyelesaian naik **37,2% → 55,6%**, tetapi tidak bermakna (p=0,137).

Kiriman ganda: dipakai kiriman paling lengkap. Valid: BB 30–200 kg & TB 120–220 cm; pengetahuan ≥39/48; sikap ≥20/24; FFQ ≥48/60; medsos butir inti; IPAQ-SF 0–7 hari & ≤960 mnt/hari. RAK: rentang antarkuartil.

3.4 Penggunaan Media Sosial — Tujuan 2 — n = 74

Pola akses · Perilaku informasi · Perlu diwaspadai

- **59,5%** Platform utama: WhatsApp
- **33,8%** Platform utama: TikTok/Instagram
- **73,0%** Akses hampir terus-menerus (±setiap jam)
- **51,4%** Durasi ≥3 jam/hari
- **87,7%** Pernah mencari info prakonsepsi[a]
- **61,6%** Selalu memeriksa kebenaran info[a]
- **75,7%** Sumber: akun nakes/lembaga resmi[b]
- **39,2%** Sumber: influencer[b]
- **71,6%** Pernah tertarik produk yang dipromosikan

Dominasi WhatsApp khas Indonesia (remaja AS hanya 23%; Faverio & Sidoti 2024) dan efektif sebagai pengingat kesehatan (Laurence et al. 2025). Ketertarikan pada produk promosi perlu diwaspadai (Agustiani et al. 2026).

Subjek: 59,5% perempuan; 60,6% berpendidikan ≤SMA; 51,4% berat badan lebih/obesitas. [a]n=73. [b]Dapat memilih lebih dari satu sumber.

3.5 Hubungan Medsos, Pengetahuan, Sikap HBM, dan IMT — Tujuan 2 — n = 74

Variabel	Pengetahuan	Sikap HBM	IMT
Frekuensi akses	−0,092 (0,436)	0,031 (0,796)	0,038 (0,746)
Durasi harian	0,175 (0,135)	0,199 (0,090)	**−0,331 (0,004)***
Mencari info prakonsepsi	0,057 (0,631)	0,216 (0,066)	−0,181 (0,125)
Memeriksa kebenaran info	0,116 (0,327)	**0,287 (0,014)***	0,042 (0,723)
Platform utama[a]	– (0,088)	**– (0,006)***	– (0,919)
Sumber nakes/resmi[b]	– (0,950)	– (0,456)	**– (0,022)***
Skor pengetahuan	–	**0,414 (<0,001)***	−0,009 (0,939)
Skor sikap	–	–	−0,212 (0,070)

Nilai: r_s Spearman (p). [a]Kruskal-Wallis (WhatsApp, Instagram, TikTok); skor terendah pada pengguna WhatsApp. [b]Mann-Whitney; median IMT 22,5 vs 26,6 kg/m². *p<0,05.

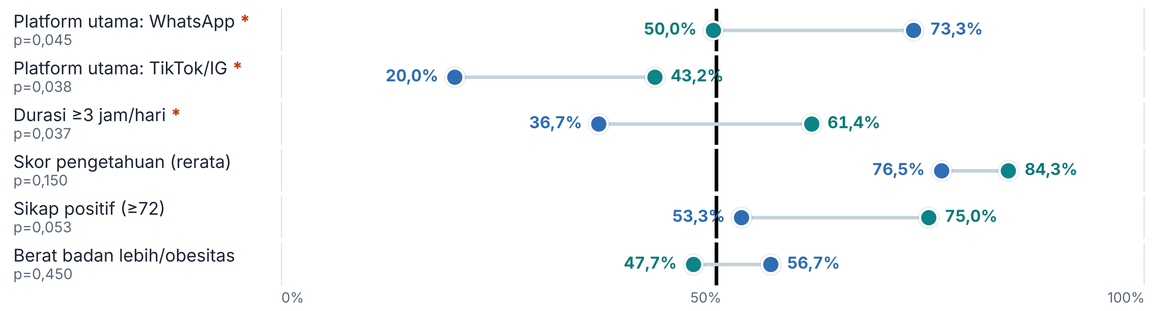
Konstruk HBM: pengetahuan paling erat dengan persepsi hambatan (r=0,449) dan kerentanan (r=0,410), tetapi tidak dengan efikasi diri; **persepsi hambatan terendah** (68,5% skor maks.).

Durasi–IMT tetap bermakna setelah dikontrol peran (r parsial=−0,315; p=0,006); perlu dikonfirmasi pada sampel lebih besar.

Cara memilih & menilai informasi lebih berhubungan dengan IMT dan sikap daripada frekuensi akses medsos (Chen et al. 2018; Denniss et al. 2024; Lam et al. 2025).

3.6 Menurut Peran Catin — Tujuan 2

Laki-laki (n=30) · Perempuan (n=44)



Catin laki-laki lebih tua dan seluruhnya bekerja; pengetahuan & sikap cenderung lebih rendah (sejalan Zahra et al. 2024), tetapi tidak lebih mudah berhenti (selesai 47,0% vs 47,9%; p=0,910).

*p<0,05 (khi-kuadrat/eksak Fisher; Mann-Whitney untuk skor).

4 Simpulan, Saran & Implikasi

SIMPULAN

- Platform web sederhana dapat dipakai untuk riset prakonsepsi online, namun **beban peserta, kiriman ganda, dan kehilangan data tak terlihat** lazim terjadi dan perlu diantisipasi sejak perancangan.
- Penggunaan medsos catin **intensif dan didominasi WhatsApp**.
- Pengetahuan gizi prakonsepsi umumnya baik dan berkorelasi dengan sikap berbasis HBM, tetapi **>50% catin berat badan lebih/obesitas**.
- IMT lebih rendah dan sikap lebih positif berhubungan dengan **sumber kesehatan kredibel dan kebiasaan memeriksa kebenaran informasi**, bukan frekuensi akses.

Saran: platform sejenis perlu instrumen ringkas dan pemantauan data rutin; edukasi gizi prakonsepsi online perlu membiasakan catin memeriksa kebenaran informasi & izin edar produk, menggunakan referensi kredibel, serta memanfaatkan WhatsApp sebagai pengingat dan pendampingan.

ENAM IMPLIKASI BAGI EDUKASI GIZI ONLINE

1. **Instrumen ringkas**; tes panjang dipecah ke beberapa kunjungan + simpan-lanjut
2. **Pengingat terjadwal via WhatsApp** untuk menekan angka berhenti
3. **Kiriman ganda & HP bersama** ditangani dengan penanda peserta dan aturan baku
4. **Penyimpanan dikonfirmasi server**; data dipantau setiap minggu
5. **Pesan sesuai peran:** laki-laki via WhatsApp; perempuan juga via TikTok/Instagram
6. **Dokumentasi perubahan** bertanggal; pemisahan kelompok kontrol–intervensi dijaga

Keterbatasan: sampel kecil, BB/TB dilaporkan sendiri, analisis eksploratif tanpa regresi, desain potong lintang; alasan berhenti tidak terekam; perbandingan sebelum–sesudah perbaikan berdasarkan periode singkat dan peserta sedikit.

5 Ucapan Terima Kasih

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
- Calon Pengantin Kota Binjai
- Seluruh pihak yang berkontribusi

Akses SHINING
mulai.edukasi-catin.id
1. Pindai QR atau buka tautan
2. Isi nama dan nomor WhatsApp
3. Baca persetujuan, lalu mulai

Pustaka utama. Amiri P et al. 2023. BMC Health Serv Res 23:1176 · Atmaka DR et al. 2022. Media Gizi Indones 17(1SP):1–5 · BPS 2025 · Chen X et al. 2018. J Health Commun 23(8):724–734 · Denniss E et al. 2024. IJBNPA 21:16 · Eysenbach G. 2005. JMIR 7(1):e11 · Eysenbach G. 2011. JMIR 13(4):e126 · Faverio M, Sidoti O. 2024. Pew Research Center · Galesic M, Bosnjak M. 2009. Public Opin Q 73(2):349–360 · Janz NK, Becker MH. 1984. Health Educ Q 11(1):1–47 · Lam BT et al. 2025. JMIR 27:e67640 · Laurence MC et al. 2025. Front Digit Health 7:1542006 · Lim MSC et al. 2022. JMIR 24(1):e23656 · Meyerowitz-Katz G et al. 2020. JMIR 22(9):e20283 · Musgrave L et al. 2023. JMIR 25:e41900 · Stephenson J et al. 2018. Lancet 391:1830–1841 · Zahra SS et al. 2024. HPCEJ 3(1)